SÉRIE REABILITAÇÃO · MATERIAL 2027

Fisioterapia Desportiva

Do tecido ao retorno ao esporte: bases científicas, avaliação, tratamento e decisão clínica

7	19	~200	95
partes	capítulos	páginas	questões comentadas

O que mudou nesta versão

A estrutura foi refeita a partir do que cobram as **pós-graduações em fisioterapia esportiva**, a **prova de título de especialista**, as **competências internacionais do fisioterapeuta esportivo** e os **principais livros-texto** da área (detalhes na página 8). Nenhum capítulo é centrado em uma modalidade: os exemplos vêm de corrida, esportes de salto, de raquete, de combate, de arremesso, ciclismo, natação e paradesporto.

- ★ **Tratamento no centro:** cada lesão vem com um **plano por fases**, exercícios-chave com dose, critérios objetivos para avançar, recursos com evidência e critérios de alta (exemplo na página 7). Os capítulos 7 e 8 ensinam a prescrever; os capítulos 9 a 16 aplicam a prescrição a cada lesão.
- \+ **Entraram:** biomecânica do gesto esportivo, dor no atleta, epidemiologia e registro de lesões, fisiologia da adaptação, lesão muscular, tendinopatias, osso e cartilagem, punho e mão, emergências no local de competição, psicologia da lesão e atleta com doença crônica.
- ↑ **Ficaram mais profundos:** avaliação funcional (plataforma de força, erro de medida), exercício terapêutico (dose, BFR, periodização) e recursos terapêuticos, cada um com a força da evidência.
- − **Saiu:** o foco em futebol; programas de prevenção aparecem pelo mecanismo, não pela modalidade.

A lógica da ordem

Partes I a III dão as ferramentas: ciência, medida e tratamento. **Parte IV** organiza as lesões pelo tecido (músculo, tendão, osso), porque a biologia é a mesma em qualquer região. **Parte V** aplica tudo região por região. **Partes VI e VII** fecham com a decisão de retorno, a emergência e as populações que exigem ajuste.

Abertura com imagem → Gancho clínico → Conceito → Avaliação → Conduta por critérios → Na prática → Caso clínico → 5 questões → Revisão → Referências

O que você vai estudar

PARTE I · BASES CIENTÍFICAS

01 Fisioterapia esportiva: atuação, raciocínio clínico e evidência ~7 p.

A especialidade e as 11 competências internacionais do fisioterapeuta esportivo
Equipe interdisciplinar e comunicação com médico e preparador físico
Raciocínio clínico: do diagnóstico cinético-funcional ao plano de tratamento
Sinais de alerta: condições graves que se disfarçam de lesão esportiva
Prática baseada em evidências e decisão compartilhada com o atleta
Ética e o fisioterapeuta diante do controle de dopagem
+ Na prática · Caso clínico · Questões · Revisão · Referências

02 Biomecânica do gesto esportivo ~9 p.

Força de reação do solo, momentos e potência articular
Corrida: padrão de apoio, cadência e calçado; retreinamento da marcha como tratamento
Salto, aterrissagem e mudança de direção: corrigir o valgo dinâmico
Arremesso e gestos acima da cabeça: a cadeia cinética na reabilitação
Ciclismo, natação, raquete e combate: padrões de sobrecarga e ajustes
Análise de vídeo 2D no consultório
+ Plano de tratamento por fases · Na prática · Caso clínico · Questões · Revisão · Referências

03 Lesão, reparo e manejo agudo ~9 p.

Modelo carga-capacidade e mecanotransdução
Tempos de reparo de músculo, tendão, ligamento, cartilagem e osso
Manejo das primeiras 72 horas: PEACE & LOVE na prática
Carga precoce: quando começar a mover e quanto
Crioterapia, compressão e anti-inflamatório: indicação e limites
Imagem para o fisioterapeuta: o que muda o tratamento e o que não muda
+ Plano de tratamento por fases · Na prática · Caso clínico · Questões · Revisão · Referências

04 Dor no atleta: avaliação e tratamento ~8 p.

Dor nociceptiva, neuropática e nociplástica: como diferenciar no exame
Educação em neurociência da dor: o que dizer e como dizer
Exposição gradual e dosagem por sintomas (regra do semáforo)
Exercício como analgésico: isometria e hipoalgesia induzida
Tratando catastrofização e cinesiofobia
Infiltrações e analgésicos: o que muda no plano de reabilitação
+ Plano de tratamento por fases · Na prática · Caso clínico · Questões · Revisão · Referências

Sumário (continuação)

PARTE II · AVALIAÇÃO, CARGA E PREVENÇÃO

05 Avaliação funcional e testes de desempenho ..... ~11 p.

Anamnese esportiva e exame físico orientado ao gesto
Força: dinamometria isocinética e manual
Potência e salto: plataforma de força, CMJ e hop tests
Índice de simetria entre membros: utilidade e armadilhas
Mobilidade e controle: lunge test, Y-balance e controle motor
Questionários validados: KOOS, IKDC, HAGOS, VISA-A, VISA-P, DASH, ACL-RSI
Erro de medida e mudança mínima detectável: quando o paciente melhorou de verdade
+ Na prática · Caso clínico · Questões · Revisão · Referências

06 Carga de treino, epidemiologia e prevenção ..... ~10 p.

Registro de lesões: o consenso do COI (2020)
Carga externa e interna: PSE da sessão e os limites da razão aguda:crônica
Modelos de prevenção: van Mechelen, TRIPP e Meeuwisse
Triagem pré-temporada: o que prediz e o que não prediz
Programas de prevenção na prática: aquecimento neuromuscular, nórdico e Copenhagen, com dose e progressão
Implementação e adesão
+ Na prática · Caso clínico · Questões · Revisão · Referências

PARTE III · O TRATAMENTO

07 Exercício terapêutico: fisiologia, prescrição e progressão ..... ~14 p.

Adaptações neurais e musculares; o destreino durante a lesão
Prescrição: intensidade, volume, repetições em reserva, frequência e descanso
Isometria, excêntrico e treino pesado e lento (HSR): quando usar cada um
Pliometria: progressão de baixa para alta intensidade
Restrição de fluxo sanguíneo (BFR): protocolo, dose e segurança
Treino neuromuscular e proprioceptivo: progressões
Condicionamento aeróbio durante a lesão: bicicleta, piscina e ergômetro de braço
Periodizar a reabilitação: as quatro fases e os critérios de passagem
+ Plano de tratamento por fases · Na prática · Caso clínico · Questões · Revisão · Referências

08 Recursos terapêuticos: indicação, dose e evidência ..... ~11 p.

Terapia manual: mobilização, manipulação e tecidos moles
Agulhamento seco, ventosa e liberação miofascial
Eletroestimulação neuromuscular após cirurgia e TENS para dor
Fotobiomodulação, ultrassom e ondas de choque: parâmetros e indicações
Crioterapia, termoterapia, compressão e hidroterapia
Bandagem funcional, bandagem elástica, órteses e palmilhas
Como combinar recursos com exercício sem perder tempo de tratamento
+ Plano de tratamento por fases · Na prática · Caso clínico · Questões · Revisão · Referências

Sumário (continuação)

PARTE IV · LESÕES POR TECIDO

09 Lesão muscular: avaliação e reabilitação ..... ~11 p.

Classificação (Munique e BAMIC) e prognóstico
Primeiros dias: proteção, carga precoce e o que evitar
Isquiotibiais: excêntrico em alongamento, nórdico, ponte e progressão de corrida
Reto femoral, adutores e panturrilha: exercícios específicos e progressão
Retorno à corrida de alta velocidade por etapas
Critérios de alta e prevenção da recidiva
+ Plano de tratamento por fases · Na prática · Caso clínico · Questões · Revisão · Referências

10 Tendinopatias: tratamento por carga ..... ~12 p.

Avaliação: testes de carga, imagem e questionários
Os quatro estágios do programa: isometria, isotônico, armazenamento de energia e gesto
Aquiles porção média e insercional: protocolos excêntrico e HSR
Patelar: programa progressivo de carga e retorno ao salto
Glútea, isquiotibial proximal, manguito e epicondilalgia: educação e exercício
Adjuntos: ondas de choque, PRP e corticoide
Ruptura do tendão do calcâneo: tratamento funcional e reabilitação acelerada
+ Plano de tratamento por fases · Na prática · Caso clínico · Questões · Revisão · Referências

11 Osso e cartilagem: tratamento e retorno ..... ~10 p.

Lesão óssea por estresse: tratamento por risco (baixo e alto)
Programa de retorno à corrida (caminhada-corrida) e ajustes de carga
Corrigir a causa: energia, calçado, cadência e volume
Reabilitação após cirurgia de cartilagem: carga e amplitude por fase
Osteoartrite no atleta e no ex-atleta: exercício e educação
Saúde óssea: carga de impacto como prescrição
+ Plano de tratamento por fases · Na prática · Caso clínico · Questões · Revisão · Referências

PARTE V · REGIÕES DO CORPO

12 Joelho: tratamento e reabilitação ..... ~15 p.

LCA: pré-reabilitação e tratamento não cirúrgico
Pós-reconstrução do LCA, fases 1 e 2: extensão, quadríceps, eletroestimulação e força
Pós-reconstrução do LCA, fases 3 e 4: corrida, pliometria, mudança de direção e gesto
Critérios de alta, retorno após 9 meses e prevenção da nova ruptura
Menisco: reabilitação após reparo e após meniscectomia; lesão degenerativa
Ligamento colateral medial: tratamento com órtese e progressão
Dor patelofemoral: exercícios de quadril e joelho, carga, educação, bandagem e órtese
Instabilidade patelar e síndrome do trato iliotibial: tratamento
+ Plano de tratamento por fases · Na prática · Caso clínico · Questões · Revisão · Referências

Sumário (continuação)

PARTE V · REGIÕES DO CORPO (continuação)

13 Tornozelo e pé: tratamento e reabilitação ..... ~11 p.

Entorse lateral: órtese funcional, progressão de exercícios e treino de equilíbrio
Instabilidade crônica: fibulares, equilíbrio, salto e quando operar
Sindesmose: tratamento conservador e reabilitação pós-fixação
Impacto anterior e posterior: tratamento
Dor plantar do calcanhar: alongamento da fáscia, HSR, palmilha e ondas de choque
Antepé: hálux, sesamoides e neuroma
+ Plano de tratamento por fases · Na prática · Caso clínico · Questões · Revisão · Referências

14 Quadril, virilha e coxa: tratamento e reabilitação ..... ~11 p.

Dor relacionada aos adutores: programa de treino ativo e Copenhagen
Dor relacionada ao iliopsoas, inguinal e púbica: tratamento
Impacto femoroacetabular: fisioterapia ou artroscopia e reabilitação pós-artroscopia
Tendinopatia glútea: educação, exercício e manejo da carga
Isquiotibial proximal e dor glútea profunda
Contusão da coxa: posição em flexão e prevenção da miosite ossificante
+ Plano de tratamento por fases · Na prática · Caso clínico · Questões · Revisão · Referências

15 Membro superior: tratamento e reabilitação ..... ~13 p.

Ombro do arremessador: alongamento posterior, escápula e rotadores
Luxação do ombro: tratamento conservador e reabilitação após cirurgia
Dor relacionada ao manguito: programa de exercícios progressivo
Epicondilalgia: carga progressiva, órtese e o que não fazer
Ligamento colateral ulnar: reabilitação conservadora e pós-reconstrução
Programas intervalados de retorno ao arremesso
Punho e mão: escafoide, fibrocartilagem triangular e dedos, com proteção para o retorno
+ Plano de tratamento por fases · Na prática · Caso clínico · Questões · Revisão · Referências

16 Coluna, cabeça e pescoço: tratamento e reabilitação ..... ~11 p.

Lombalgia no atleta: exercício, terapia manual e educação
Espondilólise no jovem: repouso relativo, progressão e retorno
Dor radicular: tratamento conservador e quando encaminhar
Cervicalgia e lesão de plexo braquial (queimação): tratamento
Concussão: exercício aeróbio sublimiar e retorno gradual em etapas
Reabilitação vestibular, oculomotora e cervicogênica
+ Plano de tratamento por fases · Na prática · Caso clínico · Questões · Revisão · Referências

Sumário (continuação)

PARTE VI · RETORNO E LOCAL DE COMPETIÇÃO

17 Retorno ao esporte e psicologia da lesão ..... ~9 p.

O contínuo: retorno à participação, ao esporte e ao desempenho
Risco e tolerância ao risco: o modelo StARRT
Bateria de testes de alta: força, salto, corrida e gesto
Prontidão psicológica: avaliar e tratar o medo de nova lesão
Do controle ao caos: a progressão no ambiente de treino
+ Na prática · Caso clínico · Questões · Revisão · Referências

18 Emergências e cuidado no local de competição ..... ~8 p.

Plano de ação de emergência e material do posto
Avaliação primária, suspeita de lesão na coluna e remoção
Parada cardíaca: RCP e desfibrilador
Insolação por esforço: resfriamento por imersão; hipotermia
Luxações, fraturas e ferimentos: imobilização e encaminhamento
Bandagem e cuidado entre provas
+ Na prática · Caso clínico · Questões · Revisão · Referências

PARTE VII · POPULAÇÕES ESPECIAIS

19 Jovem, mulher, atleta máster e paratleta ..... ~10 p.

Atleta jovem: Osgood-Schlatter, Sever e lesões da placa de crescimento, com tratamento
Atleta mulher: prevenção do LCA e manejo da deficiência relativa de energia (REDs)
Pós-parto: reabilitação do assoalho pélvico e retorno progressivo à corrida
Atleta máster: tendão, sarcopenia e osteoartrite no plano de treino
Paratleta: ombro do cadeirante, amputados e adaptações do tratamento
Atleta com asma, diabetes ou hipertensão: ajustes na reabilitação
+ Plano de tratamento por fases · Na prática · Caso clínico · Questões · Revisão · Referências

O plano de tratamento de cada lesão

Em todos os capítulos de lesão (3, 4 e 7 a 16, além do 19), cada condição é tratada no mesmo formato, para que o leitor saiba exatamente o que fazer na segunda-feira de manhã:

1. **Avaliação inicial** que define a fase de entrada e a linha de base.
2. **Plano por fases**, com objetivo, exercícios-chave e dose (séries, repetições, carga, frequência).
3. **Critérios objetivos para avançar** de fase, e o que fazer quando o atleta não os atinge.
4. **Recursos com evidência** que somam ao exercício, e os que não valem o tempo.
5. **Erros comuns e sinais de alerta** durante a reabilitação.
6. **Critérios de alta** e ligação com o capítulo de retorno ao esporte.

Exemplo resumido: reabilitação após reconstrução do LCA

Fase	Objetivo	Exercícios-chave	Critério para avançar
1 · Proteção e ativação ≈ 0–2 semanas	Extensão completa, controle do edema, ativar o quadríceps	Mobilização patelar, extensão passiva, isometria de quadríceps com eletroestimulação, elevação da perna estendida, bicicleta sem carga	Extensão completa, edema mínimo, elevação da perna sem déficit de extensão, marcha sem muletas
2 · Força e controle ≈ 2–12 semanas	Recuperar força e controle neuromuscular	Leg press, agachamento, extensora em arco protegido, ponte, step-down, equilíbrio unipodal, BFR	Força de quadríceps de cerca de 70% do lado sadio, sem derrame e sem dor ao correr no lugar
3 · Corrida e potência ≈ 3–6 meses	Introduzir corrida, pliometria e força máxima	Programa progressivo de corrida, saltos bipodais e depois unipodais, força pesada	Quadríceps e hop tests perto de 80–90% do lado sadio, aterrissagem com bom controle
4 · Gesto e retorno ≈ 6–9+ meses	Mudança de direção, desaceleração e treino específico	Cortes planejados e depois reativos, agilidade, treino com o grupo em volume crescente	Quadríceps e hop tests ≥ 90%, prontidão psicológica adequada, pelo menos 9 meses de pós-operatório e decisão compartilhada

Exemplo de formato. No livro, cada fase traz a dose completa, os sinais de alerta e o que fazer se o critério não for atingido. Os prazos são referência; quem libera a fase seguinte é o critério.

MESMO FORMATO EM TODO O LIVRO

Entorse de tornozelo, tendinopatia patelar, lesão de isquiotibiais, luxação do ombro ou concussão: o leitor encontra sempre as mesmas seis partes, na mesma ordem. Isso transforma o livro em manual de consulta rápida.

Fontes consultadas

- **Grades de pós-graduação** em fisioterapia esportiva no Brasil (presenciais e EAD) e em Portugal: núcleo comum de biomecânica, fisiologia do exercício, avaliação, lesões, recursos terapêuticos, prevenção e emergência.
- **Prova de título de especialista** (COFFITO/SONAFE): conteúdo programático do edital de 2021, com cinco eixos (tabela abaixo).
- **Competências internacionais do fisioterapeuta esportivo** (IFSPT): 11 competências, de prevenção e intervenção aguda a reabilitação, desempenho, educação e pesquisa; atualização em consenso iniciada em 2022.
- **Mestrados em fisioterapia esportiva** no Reino Unido: ciência do desempenho e da lesão, avaliação e tratamento, manejo interdisciplinar e prevenção, métodos de pesquisa.
- **Livros-texto:** *Brukner & Khan's Clinical Sports Medicine* (5ª ed.: princípios, avaliação, reabilitação e retorno, regiões, populações especiais) e *Athletic and Sport Issues in Musculoskeletal Rehabilitation* (Magee et al.: prevenção, biomecânica do gesto, manejo da lesão, populações especiais).

Cobertura da prova de título

Eixo do conteúdo programático	Capítulos
Lesões mais prevalentes no esporte	9–16
Biomecânica do gestual esportivo	2
Fatores de risco para lesões	6, 11, 19
Avaliação e critérios de retorno ao esporte	5, 17
Recursos fisioterapêuticos aplicados ao esporte	7, 8

Cobertura das competências internacionais

Área de competência	Capítulos
Prevenção de lesões e promoção de atividade segura	6, 19
Intervenção aguda e atendimento no local de competição	3, 18
Reabilitação e retorno ao esporte	7–17
Melhora do desempenho e integração com a preparação física	2, 5, 7
Prática baseada em evidências, ética e trabalho em equipe	1, 4, 8
Populações especiais	19

ANTES DE PUBLICAR

A estrutura usa o edital de 2021, o mais recente que encontrei. Antes de lançar, vale conferir o edital vigente no COFFITO e na SONAFE para alinhar o livro ao conteúdo da prova do ano.

Imagens de abertura de capítulo

Cap.	Título da abertura	Conceito da imagem (sem texto; título entra no layout)
01	O raciocínio antes da técnica	Silhueta anatômica de atleta com sistemas ligados por filamentos dourados
02	A física do movimento	Corredor translúcido com vetores de força saindo do solo
03	Carga e capacidade	Fibras de tendão sob tensão, colágeno se reorganizando em luz dourada
04	Quando a dor mente	Medula e encéfalo iluminados, sinais nervosos subindo da perna
05	O que se mede, se melhora	Joelho translúcido sobre plataforma de força com curvas de força
06	Prevenir é dosar	Linhas de carga em ondas atravessando um músculo em contração
07	A carga é o remédio	Músculo em hipertrofia com mitocôndrias e capilares iluminados
08	Ferramentas e evidência	Mãos sobre a coxa com feixes de luz entrando no tecido
09	A fibra que rompe	Isquiotibiais com microrrupturas e reparo em fios dourados
10	O tendão que se adapta	Tendão do calcâneo com colágeno alinhando sob carga
11	Osso vivo	Tíbia com trabéculas iluminadas e pontos de estresse
12	O joelho que volta a girar	Joelho 3D com o enxerto do LCA brilhando em dourado
13	A base de tudo	Tornozelo com ligamentos laterais e sindesmose destacados
14	O centro do movimento	Quadril com labrum, adutores e glúteos em destaque
15	O braço que arremessa	Ombro, cotovelo e punho em fase de arremesso
16	O eixo e o comando	Coluna e encéfalo conectados, ondas de impacto suaves
17	Do controle ao caos	Atleta translúcido saindo da sala de reabilitação para a pista
18	Os primeiros minutos	Desfibrilador, maca e luz dourada em ambiente de competição noturno
19	Cada atleta, uma regra	Quatro silhuetas: jovem, mulher, máster e paratleta em cadeira

~75
imagens (abertura + 3 figuras por capítulo)

~5.300
créditos estimados

~8.000
créditos disponíveis

0
crédito para gráficos, tabelas e fluxogramas

Ordem de produção sugerida

1. **Capítulo 12 (joelho)** primeiro: maior procura e melhor amostra comercial.
2. **Partes I a III** (capítulos 1 a 8): fixam o vocabulário e os testes usados no resto do livro.
3. **Partes IV a VII**, um capítulo por entrega, com sua revisão antes do próximo.
4. **Fechamento:** capa, sumário com páginas reais, contracapa e conferência final das referências.